ANAMNESE FRAGEN
Wie heißen Sie denn?
Das ist…..
Wie ist Ihr Vornahmen?
Das ist….
Wie alt sind Sie?
Wann genau sind Sie geboren?
Wie groß sind Sie?
Wie viel wiegen Sie zurzeit?
Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?

Seit wann haben Sie Schwindel?
Tritt der Schwindel plötzlich oder allmählich auf?
Gibt es ein Auslösender für den Schwindel? z.B. beim Aufstehen, beim Drehen des Kopfs oder in Ruhe?(hitzekollaps)
Ist der Schwindel dauerhaft oder geht er wieder weg?
Wie lange dauert eine Attacke?
Können Sie den Schwindel genau beschreiben? Ist er wie Boot?
Dreht sich alles um Sie herum?(Drehschwindel)
Haben Sie das Gefühl, selbst zu schwanken oder zu fallen?(Schwankschwindel)
Sind Sie umgekippt oder verletzt?
Ist das erstemal oder haben Sie so etwas früher schon einmal?
Wie oft haben Sie Schwindel?
Waren Sie schon einmal deswegen bei einem anderen Arzt?
Welche Untersuchungen wurden damals durchgeführt?
Gibst es etwas, das den Schwindel verstrakt oder lindert? z.B. bei Bewegung, im Stress

Leiden Sie unter Kopfschmerzen?
Haben Sie scon einmal Bewustsein verloren?
Fühlen Sie sich schwach, ohnmächtig oder schwarz vor Augen?
Haben Sie Sehstörungen? Sehen Sie Doppelt oder verschwommen?
Haben Sie Ohrgeräusche oder Hörminderung bemerkt?
Können Sie mir sagen, dass Sie Sprachstörungen oder Schlukstörungen haben?
Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Taubheitsgefühl, Krebbelngefühl haben?
Haben Sie Lähmungen?
Haben Sie Schmierblutung oder Blut im Stuhl bemerkt?

Sind Sie in letzter Zeit nervös oder fühlen sich unruhig?
Können Sie sich in letzter Zeit schlechter konsantrieren?
Fühlen Sie sich müde?
Haben Sie Herzklopfen gespürt?
Ist Ihr Hals angeschwollen?
Haben Sie Kloßgefühl im Hals?
Wie ist Ihre Appetit?Hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit verändert? Haben Sie abgenomen oder zugenohmen?
Hat sich Ihr Stuhlverhalten verandert? Wie?
Schwitzen Sie mehr oder ist Ihnen schneller kalt?Haben Sie Nachtschweiß?
Zittern Ihre Hande?
Haben Sie trockene Haut?
Fallen Ihnen vermehrte Haare aus?

Gibt es chronische Erkrankungen, von denen ich wissen sollte? z.B. Bluthochdruck, Zuckerkranheiten
Seit wann haben Sie aHT? Was nehmen Sie dagegen?Kennen Sie Dosirung? Wie oft nehmen Sie? Ist Ihr Blutdruch gut eingestellt? Wann haben Sie das lezte Mal Ihr Blutduruck gemessen? Wie hoch war er?
Seit wann haben Sie diese Kopfschmerzen? Waren Sie deswegen schon einmal bei einem anderen Arzt? Wo-Strahlen aus- Wie beschreiben- Wie stark? Was nehmen Sie dagegen?
Außer Amlodipin und Beloc- Zok nehmen Sie regelmaßig irgendwelche Medikament ein?
Haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Privatleben?
Welche Krankenheiten gibt es bei Ihren Eltern? Wie alt war Ihre Mutter, als sie gestorben ist?

Ist Ihnen Übel?
Haben Sie erbrochen?

Haben Sie verstarkste Durstt bemerkt?
Haben Sie Husten, Luftnot, Fiber?
Hat sich Ihr Appetit in der letzten Zeit verandert?
Schlafen Sie gut? Können Sie schlecht einschlafen oder durchschlafen?
Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Seit wann haben Sie dieses Problem?Wie oft können Sie zum Stuhlgang gehen? Wie sah Ihr Stuhl aus? Gibt es Blut im Stuhl?

Haben Sie Probleme beim Wasserlasen? Seit wann haben Sie dieses Problem?Wie oft müssen Sie in der nacht  zum Wasserlasen? Welche Farbe hat der Urin?
Wann hatten Sie die letzte Monatsblutung? Gehen Sie regelmäßig beim Frauenarzt? Wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrem Frauenarzt?
Haben Sie Probleme beim Geschlechtverkehr?
Wann waren Sie das letzte Mal im Urlaub?
Sind Sie vollstandig geimpft? gegen Corona und gegen die Kindheitkrankheiten

Außer Bluthochdruck und Kopfschmerzen haben Sie noch andere wichtige Krankheit? z.B. Depression oder Krebs
Haben Sie schon einmal Unfall gehabt?
Wurden Sie schon einmal operiert? Wann waren sie? Sind sie gut verlaufen? Oder hatten sie Kompliktionen?
Rauchen Sie? Wie viel Zigarette haben Sie geraucht taglich? Wie lange haben Sie geraucht?
Trinken Sie Alkohol? Was trinken Sie? Wie viel und wie oft?
Nehmen Sie irgendwelche Drogen?
Haben Sie Allergie gegen etwas? Wie reagieren Sie darauf?
Vertragen Sie Nahrungsmittel mit Gluten, Laktos und Fruktos?
Was sind Sie von Beruf?
Sind Sie verheiratet?
Wohnen Sie mit Ihrem Mann?
Haben Sie Kinder?

**Am Ende des Anamnesegespraches**

Burn-out-Syndrom,

Ich habe einen Verdacht auf ein Burn-out-Syndrom, möglicherweise aufgrund Ihres anhaltenden Stresses. Das Burn-out-Syndrom bedeutet, dass man durch langen Stress völlig erschöpft ist und keine Energie mehr hat.Aber das bleibt nur eine Vermutung, und wir sollten weitere Untersuchungen durchführen, um dies zu bestätigen. Ich werde zuerst eine körperliche Untersuchung vornehmen (machen) und etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich ein EKG schreiben, um eine Herzursache auszuschließen, und einen Ultraschall der Schilddrüse durchführen. Sobald dann alle Befunde vorliegen, bespreche ich die Ergebnisse mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, und ekläre Ihnen alles.

Danach empfehle ich Ihnen, mit Ihrem Hausarzt oder einem Psychotherapeuten über mögliche Stressbewaltıgung oder Unterstützungsangebote zu sprechen.

eine unkontrollierte Hypertonie
Ich habe einen Verdacht auf Bluthochdruck, möglicherweise aufgrund fehlender Blutdruckmessungen seit einem Monat. Aber das bleibt nur eine Vermutung, und wir sollten weitere Untersuchungen durchführen, um dies zu bestätigen. Ich werde zuerst eine körperliche Untersuchung vornehmen und etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich ein EKG schreiben, um eine Herzursache auszuschließen, und einen Ultraschall der Schilddrüse durchführen. Sobald alle Befunde vorliegen, bespreche ich die Ergebnisse mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen und erkläre Ihnen alles.

Übergabe- Vostellung-Burn-out-Syndrom

Burn-out-Syndrom

Guten Tag Herr Oberarzt, Frau Oberätztin, "Sümeyra Firat " ist mein Name.
Heute haben wir eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie.
Nun möchte ich gerne über der Fall meiner Patientin berichten. Darf ich vorstellen?
Es geht um Frau Henrike Meyer. Sie ist eine 63 jährige Patienten, geboren am 10.02.1959. Er ist 1,76 m groß und wiegt 95 kg.
Sie stellt sich wegen seit einer Stunde bestehendem Schwindel vor.
Nach Angaben der Patientin ist der Schwindel plötzlich beim Spazierengang aufgetreten.
Sie erwähnt, dass der Schwindel seit 2-3 Jahren besteht, zusätzlich anfallartig auftritt.

Laut Aussage der Patienten sind die Schwindelattacken in der letzten Zeit häufiger geworden.
Außerdem war die Patienten vor einem Jahr beim Hausarzt, jedoch ohne auffällige Befunde.
Begleitend klagt sie über Übelkeit, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Die Fragen nach neurologischen Syptomen wurden verneint.
Vegetativanamnestisch ergab sich Appetitlosigkeit, Verstopfung seit mehreren Jahren, Nykturie (1–2 Mal pro Nacht) und Schlafstörungen.
Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie eine arterielle Hypertonie seit 5 Jahren, die mit Amlodipin 5 mg (1-0-1) und Beloc-Zok 47,5 mg (1-0-1) behandelt wird, sowie rezidivierende Cephalgien seit mehreren Jahren, wogegen sie Ibuprofen bei Bedarf einnimmt. Bei der weiteren Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von ….. b.B gegen…..
Die Patienten nannte folgende Operationen: Bei ihr wurde eine Tonsilllektomi komplikationslos mit 8 Jahren, Appendektomi komplikationslos mit 13 Jahren und Hysterektomie komplikationslos vor 8 jahren durchgeführt. Die Operationen sind komplikationslos verlaufen.
Sie hat Allergien gegen Nickel und Braunpflaster. Sie reagiert mit Juckreiz und Hautausschlag.

Bei der Noxenanamnese erwähnte sie 20 Packungsjahre bis vor 5 Jahren und eine Flasche Bier am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint.
Die Familienanamnese ergab einen Apoplex beim Vater, Diabetes mellitus Typ 2 bei der Mutter und pAVK beim Bruder.
Sozialanamnestisch ist die Patienten verheiratet, lebt mit ihrem Mann zusammen und hat keine Kinder. Sie ist Bäckerin von Beruf und berichtet über viel Stress bei der Arbeit.
Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein Burn-out-Syndrom hin. Anhaltender Stress, körperliche und geistige Erschöpfung, Kopfschmerzen, rezidivierende Schwindelattacken, Schlafstörungen sowie Appetitlosigkeit sprechen dafür.
Differentialdiagnostisch kommen eine Anämie, eine unkontrollierte Hypertonieattacke sowie eine Hypothyreose in Betracht.
Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung vornehmen, die Vitalparameter überwachen, Blut fürs Labor abnehmen. Im Labor würde ich ein großes Blutbild (zur Abklärung einer Anämie), TSH, fT3, fT4 (zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion), Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Blutzucker, HbA1c sowie Ferritin kontrollieren lassen. Als routinemäßiges und wichtiges Verfahren sollte ein EKG geschrieben werden.????

Danach werde ich  eine Sonographie der Schilddrüse, Duplexsonographie der Halsgefäße durchführen und ggf. ein CT-Schädel planen.
Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapien:
Die Patientin kann ambulant behandelt werden.
Eine Patientenschulung zur Stressbewältigung und Selbstfürsorge wird empfohlen.
Eine Lebensstilveränderung (ausreichender Schlaf, regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, Reduktion der Arbeitsbelastung) spielt eine große Rolle
Bei Bedarf sollte die Patiente eine Medikamentenumstellung zur Optimierung der Blutdruckkontrolle verordnet werden. Darüber hinaus sollte die Patienten bei Bedarf Antiemetikum und Analgetikum zur Reduktion der Beschwerden erhalten.
Ich werde auch ein psychologisches Konsil zur weiteren Unterstützung anfordern.

eine unkontrollierte Hypertonie

Guten Tag Herr Oberarzt, Frau Oberätztin, "Sümeyra Firat " ist mein Name.
Heute haben wir eine neue Patientin aufgenommen. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen etwas Wichtiges mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Meier einen Kaliumspiegel von 2,6 mmol/l hat. Dieser Wert ist stark erniedrigt und entspricht Hypokaliämie.
Nun möchte ich gerne über der Fall meiner Patientin berichten. Darf ich vorstellen?
Es geht um Frau Henrike Meyer. Sie ist eine 63 jährige Patienten, geboren am 10.02.1959. Er ist 1,76 m groß und wiegt 95 kg.
Sie stellt sich wegen seit einer Stunde bestehendem Schwindel vor.
Nach Angaben der Patientin ist der Schwindel plötzlich beim Spazierengang aufgetreten.
Sie erwähnt, dass der Schwindel seit 2-3 Jahren besteht, zusätzlich anfallartig auftritt.
Laut Aussage der Patienten sind die Schwindelattacken in der letzten Zeit häufiger geworden.
Außerdem war die Patienten vor einem Jahr beim Hausarzt, jedoch ohne auffällige Befunde.
Begleitend klagt sie über Übelkeit, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Die Fragen nach neurologischen Syptomen wurden verneint.
Vegetativanamnestisch ergaben sich Appetitlosigkeit, Verstopfung seit mehreren Jahren, Nykturie (1–2 Mal pro Nacht) und Schlafstörungen.
Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie eine arterielle Hypertonie seit 5 Jahren, die mit Amlodipin 5 mg (1-0-1) und Beloc-Zok 47,5 mg (1-0-1) behandelt

wird. Sie weiß nicht, ob ihr Blutdruck gut eingestellt ist, weil sie ihn seit einem Monat nicht gemessen hat. Das letzte Mal war ihr Blutdruck bei 150/90 mmHg. Sie hat auch rezidivierende Cephalgien seit mehreren Jahren, wogegen sie Ibuprofen bei Bedarf einnimmt. Die weiteren Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von ….. b.B gegen…..
Die Patienten nannte folgende Operationen: Bei ihr wurde eine Tonsilllektomi komplikationslos mit 8 Jahren, Appendektomi komplikationslos mit 13 Jahren und Hysterektomie komplikationslos vor 8 jahren durchgeführt. Die Operationen sind komplikationslos verlaufen.
Sie hat Allergien gegen Nickel und Braunpflaster. Sie reagiert mit Juckreiz und Hautausschlag.
Bei der Noxenanamnese erwähnte sie 20 Packungsjahre bis vor 5 Jahren und eine Flasche Bier am Wochenende. Drogenkonsum wurde verneint.
Die Familienanamnese ergab einen Apoplex beim Vater, Diabetes mellitus Typ 2 bei der Mutter und pAVK beim Bruder.
Sozialanamnestisch ist die Patienten verheiratet, lebt mit ihrem Mann zusammen und hat keine Kinder. Sie ist Bäckerin von Beruf und berichtet über viel Stress bei der Arbeit.
Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine unkontrollierte Hypertonie hin, möglicherweise aufgrund fehlender ärztlicher Kontrollen und Blutdruckmessungen seit einem Monat**.** Die arterielle Hypertonie in der Vorgeschichte, rezidivierende Schwindelattacken, Kopfschmerzen sowie Schlafstörungen sprechen dafür.
Differentialdiagnostisch kommen ein Burn out Syndrom, eine Anämie, sowie eine Hypothyreose in Betracht.
Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung vornehmen, parallel die Vitalparameter überwachen, eine Langzeitblutdruckmessung planen und Blut fürs Labor abnehmen. Im Labor würde ich ein großes Blutbild (zur Abklärung einer Anämie), TSH, fT3, fT4 (zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion), Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Blutzucker, HbA1c sowie Ferritin kontrollieren lassen. Als routinemäßiges und wichtiges Verfahren sollte ein EKG geschrieben werden.????
Danach werde ich eine Sonographie der Schilddrüse, Duplexsonographie der Halsgefäße durchführen und ggf. ein CT-Schädel planen.
Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapien:
Die Patientin kann ambulant behandelt werden.
Die Patienten sollte eine Medikamentenumstellung oder die Ergänzung der Medikation zur Optimierung der Blutdruckkontrolle verordnet werden.
Darüber hinaus sollte die Patienten bei Bedarf Antiemetikum und Analgetikum zur Reduktion der Beschwerden erhalten.

Eine Patientenschulung zur Stressbewältigung und Selbstfürsorge wird empfohlen.
Eine Lebensstilveränderung (ausreichender Schlaf, regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, Reduktion der Arbeitsbelastung) spielt eine große Rolle
Ich werde auch ein Konsil in der Abteilung für Kardiologien zur weiteren Therapioptimierung anfordern.

Reaktionen:

**1)Warum fragen Sie meinen Name noch mal? Ich habe bei der Anmeldung alle Infos schon gegeben.**
Das ist wichtig für uns die Daten nochmal überprüfen, um Sie nicht mit anderen Patienten mit gleichem Namen und Alter zu werwechseln.
**2)Ich habe viele Probleme Herr Doktor. Ich möchte nicht mehr arbeiten. Ich möchte Frührente bekommen.**
Könnten Sie bitte den Grund erklären?

Frau Meyer, wir haben noch keine Diagnose gestellt. Ohne Diagnose können wir nichts sagen. Ich glaube, dass Sie zu viel Stress haben. Auf jeden Fall ist es nicht meine Entscheidung.
Für die Frührente ist die Deutsche Rentenversicherung zuständig. Dort können Sie einen Antrag stellen oder sich beraten lassen. Aber Sie werden von uns einen Brief erhalten, wenn Sie entlassen werden.
**3)Ich möchte mit dem Oberarzt sprechen, darf ich? Kann Oberarzt mir helfen?**

Der Oberarzt ist momentan mit anderen Patienten beschäftigt deswegen sollen Sie mit mir weitermachen. Ich kümmere mich um Ihre Beschwerden. Danach bespreche ich Ihren Fall mit meinem Oberarzt natürlich. Wir arbeiten hier als Team.

**4)Aber ich habe gehört, dass Ärzte dafür zuständig sind**.

Ärzte können nur Gutachten oder Befunde schreiben. Zuständig für den Antrag ist die Rentenversicherung.

**Soll das Dokument nach Berlin geschickt werden? Wie lange dauert es?**

Ja, das Antragsformular muss an die Deutsche Rentenversicherung in Berlin geschickt werden. Die Bearbeitungszeit kann variieren, normalerweise dauert es 3-5 Monate, bis eine Entscheidung getroffen wird."

**5)Die Patientin ist nicht zufrieden mit der Antwort:**

Seien Sie bitte geduldig, hoffentlich finden wir nach der Diagnose eine gute Lösung für Sie :).

**6)Sie finanziert allein alle Lebenskosten.**

Ich verstehe, das muss schwer sein. Es ist nicht einfach, sich um die Familie zu Hause zu kümmern und gleichzeitig zu arbeiten.

**7)Warum muss ich FA besuchen? Ich bekomme nicht mehr meine Periode.**

Auch nach der Menopause ist es wichtig, regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen, um die Gesundheit der Gebärmutter, Eierstöcke und der Brust zu kontrollieren.“

**8)Kann ich hier eine FA besuchen?**

Natürlich können Sie das.

**9)aHT seit 5 J. aber nimmt Medikamente seit 3 Jahren (kontrolliert den Blutdruck nicht regelmäßig, HA nicht lange besucht, Sie ist mit dem HA nicht zufrieden).**

**Ich habe meinen Hausarzt schon lange nicht mehr besucht. Eigentlich bin ich nicht zufrieden mit ihm. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob mein Blutdruck gut eingestellt ist. In letzter Zeit habe ich meinen Blutdruck gar nicht gemessen.**

Es ist wichtig, Ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen, um einen stabilen Blutdruck zu haben. Die langfristige Kontrolle von Bluthochdruck ist sehr wichtig, um das Risiko von Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenversagen zu reduzieren.

Außerdem sollten Sie regelmäßige Ihren Arzt besuchen, um den Blutdruck zu überwachen und um sicherzustellen, dass die eingenommenen Medikamente wirksam sind. Wenn Sie möchten, können wir gemeinsam nach einem neuen Hausarzt suchen. Wir sind hier, um Sie zu kümmern.

**10)Der Patient hat heute den BD nicht gemessen:**

Keine Sorge, ich werde Ihren Blutdruck bei der ärztlichen Untersuchung messen.

**11)Warum Blutdruck messen ist wichtig? Ich nehme meine Medikamente regelmäßig ein.**
Es ist großartig zu hören, dass Sie Ihre Medikamente regelmäßig einnehmen! Wenn Sie regelmaßih Ihren Blutdruck messes, können Sie das Risiko von Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenversagen zu reduzieren.
**12) Wie kann man den Blutdruck messen?**
Vor der Messung sollten Sie mindestens 30 Minuten ruhig bleiben und keinen Tee, Kaffee etc. trinken, auch nicht rauchen. Die Messung sollte am Oberarm erfolgen. Sie sollten sicher sein, dass die Manschette richtig getragen wird.
**Kann ich von Ihnen ein Blutdruckmessgerät kriegen?**
Nein aber Sie besprechen das am besten mit Ihrem Apotheker oder Hausarzt.
**13) Wie kann man den Blutdruck einstellen? Kann man mit Blutdruck gut leben?**
Sie können Ihren Blutdruck unter Kontrolle halten, indem Sie regelmäßig zum Arzt gehen, Medikamente richtig einnehmen, auf Ihre Ernährung achten und regelmäßig Sport treiben.
**14)Habe ich auch Raucherbein?**
**Am Anfang:** Ich verstehe Ihre Sorge. Aber Ich muss zuerst möglichst viele Informationen von Ihnen sammeln, um am Ende eine richtige Diagnose zu stellen. Ich bitte Sie um Verständnis!
**Am Ende:** Ich gehe zunächst nicht davon aus. Es gibt weitere harmlose Ursachen die zu Ihren Beschwerden passen könnten.
**15)Warum wurde das Bein meines Bruders amputiert?**
Das tut mir leid. Der Grund dafür könnte eine Verstopfung der Blutgefäße sein. Das ist normalerweise unsere letzte Option, aber manchmal notwendig, um Durchblutung nicht zu verschlechtern oder um eine lebensbedrohliche Infektion zu verhindern.
**16)Wird mein Bruder sein Bein verloren?**
Leider kann ich das nicht sagen. Ich muss seine Anamnese erheben und ihn körperlich untersuchen, damit ich mir ein vollständiges Bild von seinem Zustand machen kann.
**17)Sie hat eine Liste von Medikamenten auf einem Zettel. Sie fragte, ob diese Medikamente genug sind.**
Super, dass Sie Ihren Medikamentenzettel dabeihaben. Aber ich benötige mehrere Blutdruckmessungen, um beurteilen zu können, ob Ihre Medikation ausreichend ist. Wir können Ihren Blutdruck heute messen, aber ich würde Ihnen empfehlen, Ihren Hausarzt aufzusuchen, um Ihren Blutdruck regelmäßig zu kontrollieren.
**18)Machen Sie ein EKG mit dem Fahrrad?**

Das kann ich jetzt nicht sagen, zuerst müssen wir die Basisuntersuchungen durchführen, und dann können wir beurteilen, ob wir weitere Untersuchungen durchführen müssen.

**19)Ich habe Blutarmut, warum müssen Sie Blut abnehmen?**

Ich verstehe Ihre Sorge, aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Für die Diagnosestellung sind Laborwerte von großer Bedeutung. Wenn Ihre Symptome auch auf eine Blutarmut zurückzuführen sind, müssen wir die Ursache für diese Blutarmut bestimmen.

**20)Warum brauchen Sie CCT? Vermuten Sie, dass ich Hirntumor habe?**

Nein, bitte machen Sie sich keine Sorgen. Die Durchführung einer CT-Untersuchung ist eine diagnostische Methode, die uns dabei helfen kann, verschiedene Erkrankungen und Verletzungen des Gehirns zu identifizieren.

**21)Mein Patient mir sagt: ich habe Angst von allen Ärzten.**

Bitte haben Sie keine Angst. Sie sind in guten Händen, und wir versuchen unser Bestes, um Ihnen die bestmögliche Versorgung zu bieten.

**22)Ich habe keine Zuckerkrankheit. Warum messen sie meine BZ?**

Wir messen Ihren Blutzucker, um mögliche gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen.

**23) Wenn ein Patient Sie zu Beginn des Gesprächs fragt, ob Sie etwas Wasser trinken möchten, können Sie mit einer freundlichen Antwort**

wie "Ja, gerne, vielen Dank für das Angebot" antworten.

**Wenn Sie kein Wasser möchten, können Sie auch höflich ablehnen, indem Sie sagen**

"Nein, vielen Dank, ich bin in Ordnung".

**Sie könnten auch anbieten, dass Sie später etwas trinken werden, wenn Sie Zeit haben. Es ist wichtig, respektvoll und höflich zu bleiben und die Bedürfnisse des Patienten zu berücksichtigen.**

**24) Könnten Sie ein Rezept für diese Drogen schreiben?**

Ich darf nicht. Ich bin hier, um mich um Ihre Gesundheit zu kümmern, und ich würde nie etwas tun, das Ihrer Gesundheit schadet.

**25) Ist es in Ordnung, dass ich hergekommen bin?**

Na klar! Das war eine gute Entscheidung! Wir sind nur hier, um Ihnen zu helfen! Ich werde Ihnen jedoch empfehlen, in Zukunft regelmäßig Ihren Hausarzt aufzusuchen, um Ihren Blutdruck zu kontrollieren. "Keine Sorge, wir kümmern uns um Sie und werden dafür sorgen, dass Sie die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten."

**26) Ich will mein HA ändern, kennen Sie jemanden?**

Ja, natürlich! Nach diesem Gespräch können wir die Möglichkeiten besprechen. Wir könnten Ihnen helfen, einen neuen HA in der Nähe zu finden

**27) Warum soll ich im Wartebereich bleiben?**

"Wir empfehlen Ihnen, im Wartebereich zu bleiben, bis alle Untersuchungen abgeschlossen sind, damit wir schnell reagieren können, falls es zu Komplikationen kommt. Im Wartebereich stehen Ihnen Wasser und eine Kantine zur Verfügung, falls Sie etwas benötigen."

**Soll ich hier bleiben?**

Das kann ich im Moment noch nicht wissen, wir warten auf die Befunde der Untersuchung und können dann entscheiden.

**28)Wo kann ich hier bleiben, bis die Untersuchungen zu Ende sind?**

Sie können sich im Wartezimmer ruhig setzen.

**29) Haben Sie genug Betten im KH für mich?**

Ja, das haben wir. Aber wir entscheiden nach der Untersuchung, ob Sie unbedingt bei uns im Krankenhaus bleiben sollen.

**30) Ich verstehe Sie nicht gut.**

Es tut mir leid zu hören, dass Sie mich nicht gut verstehen. Möchten Sie, dass ich langsamer spreche oder meine Aussprache anpasse, um Ihnen zu helfen, mich besser zu verstehen?

## Oberarzt – Assistenzarzt Fragen & Antworten

**1)Warum hat der HA der Pat. gesagt, dass sie mehr Sport treiben muss?**

Regelmäßige körperliche Aktivität kann dazu beitragen, den Blutdruck zu senken und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren.

**2) Wenn Sie sich vorstellen, dass Ihr Bauch in vier Quadranten aufgeteilt ist, dann liegt der Blinddarm in der rechten unteren Ecke des Bauches.**

Zäkum!

**3)Sie können Ihrem Patienten erklären, dass die körperliche Untersuchung eine wichtige Methode ist,**

Körperliche Untersuchung ist eine wichtige Methode, um die Gesundheit und den Zustand seines Körpers zu bewerten. Die Untersuchung kann verschiedene Methoden umfassen, wie zum Beispiel das Abhören von Herz und Lunge, das Abtasten von Bauch und Brustkorb, das Überprüfen von Reflexen und die Untersuchung von Haut, Augen, Ohren und Mund. Diese Untersuchungen können dem Arzt oder der Ärztin helfen, festzustellen, ob es Anzeichen für Krankheiten oder andere Probleme gibt, die weitere Tests oder Behandlungen erfordern.

**4)Was bedeutet BMI?**

BMI dient zur Beurteilung, ob jemand unter, normal oder übergewicht ist. Die BMI wird berechnet Körpergewicht dividiert durch Körpergröße zum Quadrat ($kg/m^2$). Auch ein Faktor zur Berechnung des kardiovaskulären Risikos.

**5)Synkope!!! Was ist ein Hitzekollaps?**
Ein Hitzekollaps ist eine kurzzeitige Ohnmacht (Synkope), die durch Hitze und Flüssigkeitsmangel entsteht.
Der Körper verliert zu viel Wasser und Salz, das Blut wird weniger, der Blutdruck fällt – das Gehirn bekommt kurz zu wenig Blut → man wird schwindlig oder ohnmächtig..
**6)Was bedeutet eine Attacke?**
Nicht dauerhafte, vorübergehende Symptomatik.
**7) Welche Symptome sollte man erfragen/untersuchen?**
- Schmierblutung und Blut im Stuhl
- Anämie-Zeichen
- Neurologische Ausfälle (Seh-, Sprech-, Schluckstörungen)
- Gestörte Vigilanz
- Hörstörung (Hörminderung, Tinnitus)
- Fallneigung, Synkope, Nystagmus
- Verletzungen, Kopfschmerzen
- Hypothyreose

**8)Kann Obstipation eine Nebenwirkung von Amlodipin sein?**
Ja. Außerdem können Antihypertensiva Synkopen durch Hypotonie verursachen.
**9)Was bedeutet „Raucherbein“?**
Manifestation einer schweren peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK).
**10)Welche vaskuläre Herzkrankheit ist bei der Familienanamnese wichtig?**
Herzgefäßerkrankungen vor dem 60. Lebensjahr sind ein wichtiger Risikofaktor.
**11) Was ist In-vitro-Fertilisation (IVF)?**
Eine Methode zur künstlichen Befruchtung im Reagenzglas (deney tüpü).
**12)Was spricht für ein Burnout-Syndrom?**
- Erschöpfung
- Entfremdung von der beruflichen Tätigkeit
- Verringerte Leistungsfähigkeit
- Psychosomatische Beschwerden

2 grün öneee yapılan olanlar normalse → Burnout-
degilse → unkontrolleri - Hyper.

# HYPERTENSIVER ENTGLEISUNG

BURN-OUT-SYDROM

| | | |
|---|---|---|
| PD | **Name:** Henrike Meyer<br>**Alter: 63 (10.02.1959)**<br>**Größe: 1,76 m Gewicht: 86,6 kg**<br>Warum fragen Sie meinen Namen nach mal? Ich habe bei der Anmeldung alle Infos schon gegeben. | |
| Aktuelle Beschwerde | seit 1 Stunde **Vertigo** (Schwank)<br><br>anfallartig und akut (bei einem Spaziergang mit ihrem Mann).<br><br>Ähnliche Beschwerden seit 2-3 Jahren<br>mit 1x/ 1-2 Wochen<br>dauern einer Stunde<br><br>öfter aufgetreten in der letzten Zeit mit 2x-3x/Woche.<br><br>vor einem Jahr bei HA<br>✓ Ich habe viele Probleme Frau Doktor! Ich möchte nicht mehr arbeiten. Ich mache Begleitsymptome: **Nausea, leicht Cephalgie und Fatigue.**<br>✓ Aber ich habe gehört, dass Ärzte bei solchen Zuständen sind.<br>✓ Ich möchte mit dem Oberarzt sprechen darf ich? Kann Oberarzt mich helfen?<br>✓ Soll das Dokument nach Berlin geschickt werden? Wie lange dauert es.? | Was bedeutet BMI? KG dividiert durch M hoch 2<br>Ausprägung eines Übergewichts bzw. Adipositas zu erfassen<br>Faktor zur Berechnung des kardiovaskulären Risikos<br><br>Synkope!!!<br><br>Hitzekollaps: **Überwärmung des Körpers Durch Schwitzen Salz- und Wasser ist verloren.**<br><br>Ob **sie umgekippt und verletzt ist.**<br><br>Was bedeutet eine Attacke?<br>**Nicht dauerhafte vorübergehende Symptomatik**<br><br>**Fragen nach Schmierblutung und Blut im Stuhl sowie Anämie-Zeichen**<br><br>**Neurologische Ausfälle (inkl. Seh-, Sprech- und Schluckstörungen) Gestörte Vigilanz Hörstörung (Hörminderung, Tinnitus) Fallneigung und Synkope Nystagmus Verletzung Kopfschmerzen Hypothyreose** |
| VA | Inappetenz, Obstipation, Nykturie (1x-2x/ Nacht) und dadurch Dyssomnie.<br>✓ Die Patientin ist nicht zufrieden mit der Antwort<br><br>gynäkologische Anamnese: Menopause seit 15J und Menarche mit 11LJ. Warum muss ich FA besuchen.<br>Ich bekomme nicht mehr menstruation? | /Kann ich hier ein FA besuchen? |
| VE | aHT seit 5J (Medikamentös behandelt seit 3J) nicht kontrolliert regelmäßig<br>✓ Ich habe meinen Blutdruck nicht gemessen<br>Rezidivierende Cephalgie manchmal (bds. ohne Ausstrahlung / leicht erträglich (5/10))<br>✓ Warum Blutdruck messen ist wichtig? | → Ich habe meinen Hausarzt schon lange nicht mehr besucht. Eigentlich bin ich nicht zufrieden mit ihm. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob mein Blutdruck gut eingestellt ist. In letzter Zeit habe ich meinen Blutdruck gar nicht gemessen ✓ Ich will mein HA ändern. Können Sie jemand? |
| Vor-OPs | Tonsillektomie mit 8 J<br>Appendektomie mit 13 J<br>Hysterektomie vor 8 J<br>✓ Wie kann man Blutdruck messen. | Ich nehme meine Medikamente regelmäßig ein.<br>? |
| Med | Amlodipin 5mg 1-0-1<br>Beloc-Zok 47,5mg 1-0-1<br>✓ Wie kann man den Blutdruck einstellen.<br>✓ Kann man mit Blutdruck gut leben? | ✓ Kann ich Ihnen ein Blutdruckmessgerät zeigen? |
| All | Nickel und Braunpflaster | |
| Nox | 20 py (Abstinenz seit 5J)<br>C2: 1 Flasche Bier / W<br>Drogenkontakt wurde verneint | Raucherbein? **Manifestation einer schweren pAVK.**<br><br>Welche vaskuläre Herzkrankheit ist bei FA wichtig?<br>**Herzgefäßerkrankung en im Alter von weniger als 60 Jahren sind ein wichtiger Risikofaktor.** |
| FA | Vater: (80 J) im Altenheim, aHT, vor 5J an Apoplex<br>Mutter: DM Typ2, vor 5J plötzlich im Bett mit 75J verstorben.<br>Bruder: pAVK (Z.n. Amputation) und Frührentner.<br>✓ Habe ich auch Raucherbein? | |

✓ Sie fragte, ob diese Medikamente genug sind.

✓ Warum wurde der Bein meines Bruders amputiert?
✓ Wird mein Bruder sein Bein verlieren?

| | | |
|---|---|---|
| SA | Bäckerin (10 Stunde/Tag), verheiratet, keine Kinder, wohne mit Mann zusammen. | Als In-vitro- Fertilisation, kurz IVF, bezeichnet man eine Methode zur künstlichen Befruchtung im Reagenzglas |
| Fragen des Patienten | Ich möchte Frührente bekommen. Ich möchte nicht mehr arbeiten. (nicht zufrieden mit den Antworten) Ich möchte mit dem Oberarzt sprechen, darf ich? Kann Oberarzt mir helfen? Jetzt muss ich sehr lange warten, bis ich Frührente bekomme. Aber ich habe gehört, dass Ärzte dafür zuständig sind. Soll das Dokument nach Berlin geschickt werden? | |
| DD | Was spricht für Burnout-Syndrom?<br>• Erschöpfung<br>• Entfremdung von der beruflichen Tätigkeit<br>• Verringerte Leistungsfähigkeit<br>• Psychosomatische Beschwerden | ✓ Machen Sie ein EKG mit dem Fahrrad?<br>✓ Ich habe Blutwurst. Warum müssen Sie Blut abnehmen?<br>✓ Warum brauchen Sie CT? Vermuten Sie, dass ich Hirntumor habe? |
| ✓ Soll ich hier bleiben? | | |

✓ Warum soll ich im Weißbereich bleiben? ✓ Ich habe keine Zucker zuzehrt. Warum messen Sie meine BZ?

## Hypertensiver Entgleisung Henrike Meyer, Roswitha Gülpen

| Leitender Beschwerden | Begleitet Symptomen | Andere |
|---|---|---|
| Kopfschmerzen, Schwindel, Epistaxis, Abgeschlagenheit, Schlafstörungen | Emesis, Nausea | Symptomen der Komplikationen (Hirnblutung...) |

| DD | Diagnostik | Therapie |
|---|---|---|
| Hirnblutung | KU (Gewicht, Größe, Taillenumfang messen, Auskultation, Ophthalmoskopie (Augenhintergrund-Funduskopie), neurologische Untersuchung, Palpation periphere Arterien) und VP (Langzeitblutdruckmessung) | ambulante Therapie<br><br>ggf. stationäre Aufnahme und sofort Antihypertensiva Therapie |
| Migräne | EKG | Antihypertensiva<br><br>systolisch 180 mmHg -> Nitroglycerin, z.B. Nitrolingual (oral), Urapidil, Nicardipin, Labetalol (intravenös) |
| Vestibular neuritis | Labor: | Kochsalzrestriktion |
| Burn-out Syndrom | BB | Patientenschulung Lebensstilveränderung |
| | Leberwerte: Gamma-GT, ALT, AST | HNO, psychologisches, kardiologisches und neurologisches Konsilien |
| | Nierenwerte: Kreatinin, Harnstoff | |
| | E-Lyte: Kalium, Natrium, Calcium, Phosphat | |
| | BZ, Hba1c | |
| | Lipidprofil | |
| | Urin-analyse (Microalbuminurie) | |
| | Echocardiografie, Carotis-Doppler | |
| | MRT und CT-Schädel | |

| Wichtige Punkten | Procedere | Aufklärung | Reaktionen |
|---|---|---|---|
| Vertigo Typen | EKG | In ihrem Fall handelt es sich vermutlich um unkontrollierten | Die Pat hat sich am |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Blutdruck. Unkontrollierte Blutdruck kann verschiedene Probleme im Körper verursachen, einschließlich Nierenkrankheiten, Herzkrankheiten, Schlaganfalle. | Anfang über Wartezeit beklagt. Lust auf Frührente bekommen wegen Stress, Was habe ich und was haben Sie für mich vor? |

1) Wenn ein Patient Sie zu Beginn des Gesprächs fragt, ob Sie etwas Wasser trinken möchten, können Sie mit einer freundlichen Antwort wie "Ja, gerne, vielen Dank für das Angebot" antworten. Wenn Sie kein Wasser möchten, können Sie auch höflich ablehnen, indem Sie sagen "Nein, vielen Dank, ich bin in Ordnung". Sie könnten auch anbieten, dass Sie später etwas trinken werden, wenn Sie Zeit haben. Es ist wichtig, respektvoll und höflich zu bleiben und die Bedürfnisse des Patienten zu berücksichtigen.

2) Mein Bruder hat Frührente bekommen. Ich möchte auch Frührente bekommen. (Sie hat mehrere Male um "Frührente" gebeten, ich habe gesagt: Könnten Sie bitte den Grund erklären? (wahrscheinlich wegen Stress) Ich möchte nicht mehr arbeiten.

3) Die Patientin war damit nicht zufrieden und sagte jetzt muss ich sehr lange warten, bis ich Frührente bekomme. Bitte seien Sie geduldig, hoffentlich finden wir nach der Diagnose eine gute Lösung für Sie

4) finanziert allein alle Lebenskosten? man muss Empathie zeigen!! Ich verstehe, das muss schwer sein. Wie schaffen Sie das? Es ist nicht einfach, sich um die Familie zu Hause zu kümmern und gleichzeitig zu arbeiten. Du bist wirklich eine Superfrau.

5) Ich verstehe, Herr Meyer, dass Sie in den Frühruhestand gehen wollen, vielleicht leiden Sie unter Stress. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Nach der Behandlung kann ich mit Ihrem HA sprechen und vielleicht kann er Ihnen helfen. Wenn das nicht hilft, kann ich auch mit meinem OA sprechen und wir werden sehen, wie wir Ihnen helfen können, also machen Sie sich keine Sorgen.

6) Natürlich können Sie mit meinem Oberarzt sprechen. Nach diesem Gespräch werde ich ihm Bescheid geben. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. (wir arbeiten in einem Team).

7) Kann Oberarzt mir helfen? Wahrscheinlich ja, er kann z.B. mit Ihrem HA sprechen, um über Möglichkeiten zu sprechen.

8) Aber ich habe gehört, dass die Ärzte dafür verantwortlich sind. Sie haben Recht, aber jeder Arzt ist in seiner Position in dieser Position eingeschränkt. Das heißt, wenn ich im Krankenhaus arbeite, könnte ich keine Frührente schreiben, die Ärzten bei der Deutschen Rentenversicherung müssen ihren Gesundheitszustand beurteilen. Aber keine Sorge, wir schreiben Ihnen einen Brief, und versuchen Ihnen zu helfen.

9) Soll das Dokument nach Berlin geschickt werden? Wie lange dauert es? "Ja, das Antragsformular muss an die Deutsche Rentenversicherung in Berlin geschickt werden. Die Bearbeitungszeit kann variieren, normalerweise dauert es 3-5 Monate, bis eine Entscheidung getroffen wird."

10) Warum muss ich FA besuchen? Ich bekomme nicht mehr meine Periode. Auch wenn keine Menstruation mehr stattfindet, gibt es immer noch gesundheitliche Probleme, die im Zusammenhang mit der weiblichen Fortpflanzung auftreten können. Ein Frauenarzt kann beispielsweise helfen, Wechseljahresbeschwerden zu lindern, Osteoporose zu vermeiden, die Gesundheit der Brust zu überwachen und Krebserkrankungen wie Gebärmutterhalskrebs oder Brustkrebs zu erkennen

11) Kann ich hier eine FA besuchen? Natürlich können Sie das! Wir haben in der Uniklinik die besten Ärzte der Welt, und wir kümmern uns um Sie!

12) aHT seit 5 J. aber nimmt Medikamente seit 3 Jahren (kontrolliert den Blutdruck nicht regelmäßig, HA nicht lange besucht, Sie ist mit dem HA nicht zufrieden). Es ist wichtig, Ihre Medikamente regelmäßig einzunehmen, um einen stabilen Blutdruck zu gewährleisten. Die langfristige Kontrolle von Bluthochdruck ist sehr wichtig, um das Risiko von Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenversagen zu reduzieren. Außerdem sollten regelmäßige Arztbesuche eingeplant werden, um den Blutdruck zu überwachen und um sicherzustellen, dass die eingenommenen Medikamente wirksam sind. Wenn Sie möchten, können wir Ihnen einen neuen Hausarzt empfehlen. Wir sind hier, um uns um Sie zu kümmern

13) hat heute den BD nicht gemessen: Keine Sorge, ich werde Ihren Blutdruck bei der ärztlichen Untersuchung messen.

Sozialanamnese

- im Bäcker tätig
- 8-10 Stunden täglich arbeiten
- verheiratet
- lebt mit ihrem Mann zusammen
- keine Kinder
- viel Stress bei der Arbeit und im Privatleben

Familienanamnese

Mutter: verstorben an unklarer Todesursache, DM Typ II, Adipositas
Vater: Apoplex vor 5 Jahren, im Altenheim,
Bruder: pAVK, linkes Bein - Amputation, Frührentner

Verdachtsdiagnose

Burn-Out Syndrom

Differentialdiagnose

- unkontrollierte aHT
- Anämie
- Hypothyreose

weitere Procedere

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor: BB, Entzündungsparameter, Nieren-Leberwerte
  Elektrolytwerte, Ferritin, Transferrin,
  Vitamin B12, Folsäure, Schilddrüsenparameter (TSH, T3, T4, B2,
- Sonographie - SD
- ggf. CT-Schädel
- ggf. Duplexsonographie - Carotis
- psychologisches Konsil

Therapie

- ambulante Behandlung
- Patientenschulung (Stressbewältigung, Lebensstilveränderung)
- ggf. Medikamentenumstellung

psycho — Psikiatri
physi — Fiziksel R.

Patientin

Vera Hoppenstedt
63 J.

* 10.07.1959

1,76 m 86,6 kg

Burn-Out-Syndrom

Hauptbeschwerde

- seit 1 Stunde ~~plötzlich auf~~ bestehender, plötzlich aufgetretener alloczenartiger Schwindel
- ähnliche Beschwerde: seit 3 Jahren, früher 1-2 Mal/Woche, letzte Woche 3-4 Mal/Woche, Dauer: 15 Minuten
- drückende, ziehende, leichte Kopfschmerzen im ganzen Kopf
- die Schmerzintensität: 3/10 auf der NRS

Begleitsymptome

- Müdigkeit
- ~~Nau~~ Übelkeit
- Eingeengefühl

vegetative Anamnese

- Inappetenz
- Dyssomnie
- Nykturie (1-2 Mal, seit 6 Monaten)
- Verstopfung (seit 3 Jahren, 3 Mal/Woche)

Voreinnahmen

- aHT seit 5 Jahren (letzte Messung: 130/90)

OPs:

- Tonsillektomie mit 8. Lj.
- Appendektomie mit 13. Lj.
- Total-Hysterektomie vor 8 Jahren

Medikamente

- Amlodipin 5 mg (1-0-1)
- Beloc-Zok 47,5 mg (1-0-1)

Allergie/Unverträglichkeit

keine

Genussmittel

Nikotinkonsum: ca. 20 py (Abstinenz ~~Abstinenz~~ seit 5 Jahre)
Alkoholkonsum: 1 Flasche Bier am Wochenende
Drogenkonsum: 0

Therapie

Stufe 1 → Monotherapie
ACE Hemmer oder AT1-Blocker oder Calciumantagonist oder Thiazid Diuretikum

Stufe II → Kombinationstherapie
zwei Wirkstoffe
ACE Hemmer oder AT1-Blocker + Diuretikum oder ACE Hemmer oder AT1-Blocker + Calciumantagonist

Stufe 3 → Dreifachtherapie
ACE Hemmer oder AT1-Blocker + Calciumantagonist + Diuretikum

Stufe 4 → Resistenter Hypertonus
zusätzlich Spironolacton oder andere Wirkstoff

Die Therapiestufe richtet sich nach der Höhe des Blutdrucks, dem Kardiovaskulären Gesamtrisiko und dem Therapieansprechen
bedeutet gemeint

Carotis Doppler ist zu empfehlen bei:
- aHT
- MI
- Herzinsuffizienz
- HRST (Vorhofflimmern, Herzstolpern)
- Diabetes Mellitus

BPLV?
BPPV → Benign paroxysmal positional Vertigo

D → BPPV ist eine gutartige, anfallartige Form des Lagerungsschwindels, dadurch bestimmte Kopfbewegungen ausgelöst wird

U → Ablösung (Degeneration) von kleinen Kalzikristallen (Otolithe) im Innenohr, die in einen Bogengang gelangen und dort falsche Drehreize auslösen

T → Spezielle Lagerungsmanöver (Epley Manöver) zur Rückführung der Kristalle. Medikamente sind meist nicht notwendig

→ wird durch frei bewegliche Otolithen im Innenohr verursacht

isolations patient → er muss wegen Ansteckungsgefahr im Zimmer bleiben.

Morbus Meniere

Morbus Meniere ist eine Erkrankung des Innenohrs mit Schwindelanfällen, Hörverlust, und Tinnitus, verursacht durch eine Störung des Endolymphhaushalts (Endolymphdruckerhöhung). Die Therapie besteht aus salzarmer Ernährung, Diuretika und symptomatischer Behandlung

Palliativpatient → er bekommt Hilfe gegen Schmerzen und zur Linderung
Ambulanter Patient → er kommt zur Behandlung und geht danach nach Hause
Stationärer Patient → er bleibt zur Behandlung im Krankenhaus
Notfallpatient → er braucht sofort Hilfe
Intensivpatient → er wird auf der Intensivstation überwacht.
Postoperative Patient → er wurde gerade operiert und braucht Kontrolle
Pädiatrische Patient → er ist ein Kind in Behandlung
Geriatrische Patient → er ist ein älterer Mensch mit mehreren Problemen
Patient → er wird gegen Krebs behandelt

## Blutdruckmessung

Setzen Sie sich bitte ruhig hin, legen Sie die Manschette am Oberarm an und drücken Sie auf Start. Danach lesen Sie den Wert ab.

## Langzeitblutdruckmessung

Sie tragen ein kleines Gerät für 24 Stunden das Ihren Blutdruck automatisch mehrmals misst, auch nachts, damit wir genaues Bild bekommen

- ~~isolierten~~ Hypertonie

Optimal → 120/80 >
Normal → 130/85 mmHg >
Hoch Normal → 130/85 – 139/89 mmHg
Hypertonie Grad I → 140/90 – 159/99 mmHg
Hypertonie Grad II → 160/100 – 179/109 mmHg
Hypertoni Grad III 180/110 mmHg <

Hypertensive Krise → rasche RD ~~Anstieg~~ Anstieg ohne Organschäden
Hypertensive Notfälle → (180/120 <) rasche RD Anstiegen mit Organschäden
Hypertensive Entgleisung → krisenhaft erhöhte Blutdruckwerte, ob mit oder ohne weitere Symptome
Einteilung nach Ursache bei Kindern meist 30 kg <
primäre Hypertonie → bei Erwachsenen 90/90, die ohne erkennbare sekundäre Ursache entsteht,
secundäre Hypertonie → 10/10 die als Folge einer anderen Grunderkrankung auftritt

- OSAS (häufigste Ursache) auftritt
- Erkrankungen der Nieren
- Hormone
- Gefäßerkrankungen
- Psychogen
- Neurogen

## RR → Riva Rocci

Antihypertensiva → Blutdrucksenker → AB CD
- A: ACE Hemmer, AT1 Rezeptorblocker
- B: β Blocker
- C: Calciumkanalblocker
- D: Diuretika

| Krise | Notfälle |
|---|---|
| Kopfschmerzen | Hirnblutung, Schlaganfall |
| Benommenheit | Hypertensive Encephalopathie |
| Schwindel | Herzinsuffizienz |
| Übelkeit | ~~Herz K~~ Kardiale Dekompensation |
| Schlafstörungen | |
| Unruhe, Nervosität | Niereninsuffizienz |
| | Aortendissektion |

## Donisch

Beruhigen Sie sich bitte
Ich brauche ein bisschen Geduld von Ihnen
Es wäre besser, wenn Sie ein bisschen Geduld haben
Versuchen Sie sich zu beruhigen

## HELLP-Syndrom

Das HELLP-Syndrom entsteht durch eine generalisierte Endothelschädigung und Mikroangiopathie in der Schwangerschaft, meist im Rahmen einer Präeclampsie, mit Hämolyse, Leberzellschädigung und Thrombozytenverbrauch.

Die definitive Therapie des HELLP-Syndroms ist die rasche Entbindung nach Stabilisierung der Mutter mit Blutdruckkontrolle, Magnesiumsulfat, Kortikosteroiden und ggf. Blutprodukten.

## Beloc-ZOK

ist ein Betablocker.
Wirkstoff ist Metoprolol

ZOK → Zero-Order-Kinetik
Dieses Medikament wird langsam freigesetzt.
bei der normalen Tablette wird der Wirkstoff schnellen freigesetzt.

(1) Wie viele Wirbel gibt es im Körper?
Der Menschen hat normalerweise 33 Wirbel

7 Halswirbel HWS
12 Brustwirbel BWS
5 Lendenwirbel LWS
5 Kreuzwirbel (verwachsen → Kyphosis-bilaris)
4 Steißbeinwirbel (verwachsen " )

Kreuz = Sakrum.
Steiß = Coccyx.

(2) Wie viele davon sind frei beweglich?
24 Wirbel sind frei beweglich

(3) Welche Typen von Mandeln gibt es?
Es gibt insgesamt 4 Arten von Tonsillen im Rachenraum
Tonsilla palatina → Gaumenmandel (seitlich im Rachen)
Tonsilla pharyngea → Rachenmandel (hinter der Nase, „Adenoid")
Tonsilla lingualis → Zungenmandel (Zungengrund)
Tonsilla tubaria → Tubenmandel (nahe Ohrtrompete)

# Hypertensive Entgleisung

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Henrike Meyer/ Vera Hoppenstedt/ Hilke Morgenroth
Alter: 63 Jahre (geb. am 10.02.1959)
Größe: 1,73 m
Gewicht: 86,6 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

**Hauptbeschwerde:**

- Seit 1.5 Stunden plötzlich aufgetretener, bestehender, attackenartiger Schwankschwindel.
- Auslöser: keine
- Lindernde Faktoren: keine
- Verstärkende faktoren: keine
- ähnliche Beschwerden: Seit 2 J., 1 mal/Wo., progredient (in den letzten 2 Wo. :4 Attacken/ Wo.)
- Begleitsymptome:
  Nausea ohne Emesis seit 3 Tagen
  Müdigkeit
  Kopfschmerzen (bds. , rezidivierend)

**V/A:**

Inappetenz
Obstipation
Insomnie wegen Nykturie

**Gyn:**

Menopause seit 15J.

**V/E:**

aHT seit 5 J. (unkontrolliert, letzte Messung 150/90 mmHg)
Kopfschmerzen seit 10J. (drückend, bds., 5/10 auf der NRS)

**M:**

Beloc-ZoK, 47,5mg 1-0-1
Amlodipine 5 mg 1-0-0.

**Vor-op:**

Tonsillektomie mit dem 8 Lj. komplikationslos
Appendektomie mit dem 13 Lj. komplikationslos
Hysterektomie vor 8J. komplikationslos

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**
  Nickelallergie und braunes Pflasterallergie (Exanthem, Pruritus )

- **Genussmittel/ Drogen:**

- Nikotinkonsum: Ex-Raucherin seit 5 J., früher 10 Zig./Tag, seit dem 18. Lj.
- Alkoholkonsum: 1Fl. Bier/ W.
- Drogenkonsum: wurde verneint.

- **Sozialanamnese:**
  Bäckerin, Stress bei der Arbeit, nicht zufrieden
  verheiratet
  Ehemann: arbeitslos
  Keine Kinder

- **Familienanamnese:**
  Vater: Z.n. Apoplex
  Mutter: verst. Mit dem 75 Lj, DM, Adipositas,
  Bruder: pAVK im linken Bein (Amputation)

- **Verdachtsdiagnose:**
  Hypertensive Entgleisung / Burnout-Syndrom

- **Differentialdiagnose**
  Hypothyreose
  Anämie

- **weitere Diagnostik**
- KU
- EKG
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - TSH,fT3, fT4, FOBT, Lipidprofil
- Urinstatus
- Thorax-Röntgen
- Ggf. CCT

- **Therapievorschläge**
- ambulante Therapie
- Lebensstiländerungen:
- Patientenschulung
- Antiemetikum
- Analgetikum
- Antihypertensivum